جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نجاح رزق عبدالله سليمان
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** اخري **العنوان :** _____
رقم البطاقة : 26001020100065 **رقم التليفون :** 01064065640 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 02-01-1960 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : ورم خبيث بالمبيض
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : ورم خبيث بالمبيض
خطة العلاج : أورام كيماوي بروتوكول علاج كيماوي ما بعد الجراحه (Platinum +Paclitaxel) [14247] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نجاح رزق عبدالله سليمان
National ID: 26001020100065

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of ovarian cancer for Paclitaxel + Platinum Protocol

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





٠١٠٦٤٠٦٥٦٤٠

National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient's Name:	**Najah Rizk Abdallah Suleiman**
Date:	**2026-07-26**
Referred by:	**Prof.Dr. an doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

A reported case of ovarian cancer, compared to the previous CT report dated 9/4/2026, the current examination revealed

I- CHEST:

- Newly developed bilateral variable sized pulmonary nodules, the largest is seen in left apical lobe measures about 1.1x1 cm
- Newly developed mild left sided pleural effusion.
- Subcentimeteric mediastinal lymph node enlargement.
- Average cardiac size.
- Bilateral fibroelastoma dorsi are noted.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Newly developed retroperitoneal soft tissue lesion is seen between liver and right kidney measures about 4.1x4 cm ?? deposits
- The liver is enlarged in size showing homogenous fatty parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- The gall bladder is well distended, average wall thickness with no stones.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen (splenule measures about 1.3 cm), pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticular or stones.
- Progressive course regarding size of the previously noted left adnexal complex cystic lesion with soft tissue component measures about 5.5x5.8 cm in its maximum axial dimensions compared to 3.6x2.2 cm
- Bulky uterus with thickened hypodense endometrial lining measures about 3 cm
- Enlarged abdominal and pelvic lymphadenopathy, the largest is seen left para-aortic measures about 9.7 mm .

Scanned with CamScanner

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name: نجاح رزق عبدالله سليمان	
MR. : 6649	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

Ovarian cancer diagnosed in 2020, treated with 6 cycles of taxol and carboplatin. In 2022, recurrent disease was managed with a rechallenge of taxol/carboplatin followed by a switch to gemzar and cisplatin. The most recent imaging in January 2026 (CT CAP) demonstrated stable disease of the Adexal mass and peritoneal deposits, with a CA 125 level of 173. A new CT CAP and CA 125 were ordered for further assessment.

A subsequent CT scan performed on 7/26/2026 revealed newly developed bilateral pulmonary nodules, the largest measuring 1.1 cm, as well as a newly developed retroperitoneal soft tissue lesion measuring 4 cm and progression of adnexal masses. CA 125 was noted to be 2278. A multidisciplinary team discussion recommended taxol/cisplatin/Avastin for HRD, with a regimen of taxol 175 mg/m² q 21 days, cisplatin 75 mg/m² q 21 days with hydration, and Avastin 7.5 mg/kg q 21 days (weight 77 kg, height 160 cm) for cycle 1. Laboratory values were accepted as of 26/8/2026.

The clinical pharmacy note dated 29/08/2026 indicates that for week 1 of cycle 1, the patient received taxol 300 mg, cisplatin 70 mg on days 1 and 8, and Avastin 577 mg on day 8 with cisplatin 70 mg only. The patient has completed 1 cycle of paclitaxel + cisplatin.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : خالد عبد العزيز محمد كمال

يعتمد ,

Patient's Name:	**Najah Rizk Abdallah Suleiman**
Date:	**2026-07-26**
Referred by:	**Prof.Dr. no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

- No ascites.
- **The examined skeleton** no worrisome lytic or sclerotic lesions

Opinion:

- **Progressive course since the last CT report for further PET/CT**

Dr.Nourhan Ramzy

Dr.Nourhan Ramzy

Scanned with CamScanner

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

[[DOCTYPE:OTHER_DETAILED_REPORT]]
detailed-report

جوستاف روسي انترناشونال

إسم المريض ثلاثي: .....

رقم الملف: .....

تقريـر طبـي

السيد/.....

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من ..... بشـان تقرير طبي للمريض: م/ أنجا [illegible]

بقسم.....رقم طبي .....

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول.....تاريخ وساعة الخروج.....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dear Sir

May I refer to your the file pt. 667

old lady Recurrent Cancer

Ovary Stage IV met to Lung, Liver

BRCA1, 2 NO Mut

Mar 2020 Stage IV Cancer Ov

Rec TC x 6 cycles

PD for 24

Taxol/plat x 6 cycles

2nd Recurrence 2025 Gemzar/plat x 6 cycles

2026:→ New. PD Met to Lung

pt started Taxol/plat

waiting for Avastin

NO approval at MOH

تحريرا في

الوقت: ..... **التاريخ :** / /

الطبيب المعالج

.....

يعتمد ،،